

INTRODUCCIÓN

La esencia de la labor del educador es preparar al hombre para la vida, a partir del desarrollo de sus potencialidades y la modificación de sus actitudes y concepciones. Si los docentes brindan la orientación y ayuda necesaria a la familia se podrá formar un sujeto capaz de asumir los retos que le imponen las condiciones sociales, psicológicas, ambientales, y biológicas en que se desenvuelven.

El desarrollo del ser humano es un proceso de modificación, de movimiento, de ser y actuar que busca cambiar las formas obsoletas e inoperantes, hacia formas nuevas, eficaces, más completas, maduras y operativas del pensamiento. Esto presupone cambios, transformaciones hacia un aprendizaje, pues se asimila algo nuevo sobre la base de lo que se conoce o se posee, por tanto, implica una modificación del esquema conceptual de referencia que se tenía por uno nuevo, diferente al anterior pero más eficaz.

Para poder impulsarlos, se necesita de puntos de orientación y de distintos niveles de ayuda que le permiten al hombre transitar por el camino adecuado.

La orientación familiar es una alternativa de la educación sistemática que prepara a la familia para el desempeño de sus funciones sobre todo la socializadora y educativa la cual permite coordinar entre las familias y los educadores las acciones necesarias para influir sobre los educandos, en un espacio de reflexión y debate en torno a temas de interés colectivo referentes a la educación de sus hijos con la intencionalidad de elevar la preparación de ellos y estimular su desarrollo.

Es por ello, que diferentes autores hacen referencia hacia la orientación familiar como, Torroella, G. (1984), Collazo y Puentes (1992), Ibarra, L. (1993); Suárez,(1999), García (2001), Martínez, C.(2001); Brito, T.(2002);Ramírez (2003), Arias, G. (2003, 2006), Torres, G.M. (2001, 2004); Moncada y Cubela (2005), Del Pino y Recarey (2006) Pérez (2007), Castro, P.L. (1990, 1996, 1999, 2004, 2008) Ferreiro (2010) y Fera (2012),; Ares, P. (1998, 2015); Pupo, R.M.(2012, 2016) entre otros, los cuales coinciden en elementos básicos referenciando que cuando la familia adquiere ciertos conocimientos y desarrolla

habilidades sociales y educativas pueden ser capaces de autorregular su función educativa. Pero no se alude en sus referencias el tratamiento a los trastornos del lenguaje entre ellos a la tartamudez.

Trastorno que tiene un componente psicológico social de influencia entre las relaciones personales que se establecen entre el niño, el entorno, la familia, y la escuela donde lo formativo en su desarrollo comunicativo afecta la fluencia verbal y el ritmo del lenguaje y para lo cual amerita la preparación de la familia para su atención, con una mirada preventiva, correctiva y compensadora desde la primera infancia con énfasis en la etapa preescolar momento donde el niño accede a la condición de escolar.

La escuela es el centro de aglutinamiento social y educativo comunitario más importante por lo cual la autora ha centrado su investigación en la escuela Ernesto Aranguren donde realiza su práctica laboral que está insertada en la comunidad Los Bulevares de Guanabo donde se detectaron como **Situación Problemática:**

- ✓ El incorrecto proceder familiar en la etapa del tartaleo fisiológico.
- ✓ Desconocimiento familiar de los factores de riesgo para el surgimiento de la tartamudez.
- ✓ En la familia se evidencian conductas y patrones lingüísticos inadecuados con los niños que presentan alteraciones en la fluencia verbal.

A partir de lo antes expuesto se plantea como **problema científico:** ¿Cómo contribuir a la orientación familiar para la prevención de la tartamudez en la etapa preescolar?

Para su solución se declara como **objetivo:** Proponer un folleto de orientación familiar para la prevención de la tartamudez en la etapa preescolar de la escuela primaria Néstor Aranguren en Guanabo.

Para el estudio del problema científico de la investigación se proponen las siguientes **preguntas científicas**.

1. ¿Qué referentes teóricos metodológicos sustentan la orientación familiar para la prevención de la tartamudez en la etapa preescolar?
2. ¿Cuál es el estado inicial de la orientación familiar para la prevención de la tartamudez en la etapa preescolar de la escuela primaria " Néstor Aranguren" en Guanabo?
3. ¿Qué contenido debe poseer un folleto de orientación familiar para la prevención de la tartamudez en la etapa preescolar?
4. ¿Qué criterios valorativos se obtienen con la aplicación del folleto de orientación familiar para la prevención de la tartamudez en la etapa preescolar en la práctica pedagógica?

Para darle solución a las preguntas se trazaron las siguientes **Tareas científicas**:

1. Sistematización de los referentes teóricos-metodológicos que sustentan la orientación familiar para la prevención de tartamudez en la etapa preescolar.
2. Caracterización del estado inicial de la orientación familiar para la prevención de la tartamudez en la etapa preescolar de la escuela primaria Néstor Aranguren en Guanabo.
3. Elaboración de un folleto de orientación familiar para la prevención de la tartamudez en la etapa preescolar.
4. Valoración del resultado obtenido de la propuesta del folleto de orientación familiar para la prevención de la tartamudez en la etapa preescolar en la práctica pedagógica.

Los métodos empleados en esta investigación fueron:

Métodos del nivel teórico:

Analítico-sintético: en el estudio de las concepciones sobre la tartamudez y los métodos de intervención, para el diagnóstico, analizar los resultados y elaborar el informe.

Inductivo–deductivo: para establecer generalizaciones que constituyen el sustento teórico de la respuesta pedagógica adoptada y para su elaboración.

Modelación: en la elaboración de contenido y la estructura del folleto de orientación familiar para prevenir la tartamudez en la etapa preescolar.

Métodos del nivel empírico.

Observación: de las actividades educativas en el círculo infantil, vías no formales, gabinete logopédico, actividades extraescolares, para estudiar las particularidades del desarrollo de las niñas y los niños, así como el ambiente escolar y familiar en que viven.

Encuesta: A la familia de los niños para constatar el nivel de conocimiento familiar acerca de la ontogénesis del lenguaje.

Entrevista: A padres para evaluar el estado de la orientación familiar sobre la prevención de la tartamudez en la etapa preescolar y a los agentes comunitarios para caracterizar la comunidad objeto de estudio.

Exploración logopédica: a educandos que componen la muestra para la caracterización y el diagnóstico de sus necesidades educativas, determinar las potencialidades y comprobar la efectividad de la ayuda, para la evaluación de la puesta en práctica de la propuesta que se aplicará.

Análisis documental: en la sistematización de la información de textos científicos de orientación familiar para la prevención de la tartamudez en la etapa preescolar y de documentos rectores y legales.

Consulta a especialistas y usuarios: permitió evaluar la variable de la investigación, los indicadores y la propuesta.

Métodos del nivel matemático-estadístico:

Análisis porcentual: permitió el procesamiento de los datos obtenidos en los instrumentos aplicados para determinar regularidades en estos.

La actualidad de la investigación se expresa en la puesta en práctica de un folleto de orientación familiar, que contribuya a la prevención de la tartamudez a partir de acciones coordinadas con los diferentes agentes educativos comunitarios (familia, organismos, organizaciones, instituciones, entre otros) para que contribuyan a la formación y desarrollo de buenas habilidades comunicativas. El trabajo se inserta en el proyecto de investigación “Buenas prácticas socioeducativas comunitaria para el desarrollo de la comunicación y el lenguaje en niños/as, adolescentes, jóvenes y adultos”, de la cátedra Ricardo Cabanas Comas de la carrera de Logopedia, de la facultad de Educación Infantil.

La investigación consta en la introducción el diseño teórico-metodológico que orienta la investigación, se señala la actualidad científica, que revela la importancia social del tema y su pertinencia. En el desarrollo se abordan los referentes teóricos-metodológicos relacionados con la orientación familiar para la prevención de la tartamudez en la etapa preescolar, se incluyen los indicadores, se precisa el diagnóstico de la situación actual del problema que se investiga, y los resultados evidenciados, así como el análisis teórico metodológico de la propuesta de folleto de orientación familiar para la prevención de la tartamudez en la etapa preescolar para dar solución al problema investigado. Se señalan las conclusiones, recomendaciones, bibliografía y anexos para su continuidad en otras investigaciones. Se ha socializado el trabajo en eventos como el Gusto por la Ciencia y otros espacios científicos.

CAPÍTULO I: REFERENTES TEÓRICOS Y METODOLÓGICOS QUE SUSTENTAN LA ORIENTACIÓN FAMILIAR PARA LA PREVENCIÓN DE LA TARTAMUDEZ EN LA ETAPA PREESCOLAR

Este capítulo hace alusión a los referentes teóricos y metodológicos relacionados con la orientación familiar para la prevención de la tartamudez en la etapa preescolar, se enfatiza en esta etapa pues es donde ocurren las mayores dificultades y tropiezos en el lenguaje.

1.1 La orientación familiar. Contextualización

La familia es el entorno más próximo al niño, así como el elemento más decisivo en la formación del individuo, estableciendo contactos periódicos con el centro escolar al que asiste el niño, con la finalidad de compartir información sobre su desarrollo y proceso de adaptación al ámbito escolar, crear un marco de colaboración y dar soporte y orientación en las situaciones que lo requieran. El objetivo básico de la relación familia- escuela es ensamblar ambos sistemas en una actitud colaborativa de resolución de los problemas mutuos, comunes, actitud que implica cambiar la manera de pensar, entender, o definir el problema, examinar las creencias que sostienen esa conducta y reflexionar sobre lo que se ha venido haciendo respecto del mismo.

La orientación con y para la familia ha de mantenerse en el sentido de la ética profesional, se ha de expresar no en la mera intuición sino en el ofrecimiento de un folleto de orientación desde la preparación científica, esto favorecerá el proceso de orientación familiar en las diferentes esferas de actuación profesional en que se llevará a cabo el proyecto, tales como Círculos Infantiles, Escuelas Primarias y el Programa “Educa a tu Hijo”. Las acciones de orientación se integran al proceso de educación como parte de la tarea de educar y de la función orientadora del rol profesional del educador.

En este campo son reconocidos los trabajos de orientación familiar realizados por autores como, Torroella, G. (1984), Collazo y Puentes (1992), Ibarra, L. (1993); Suárez,(1999), Díaz (2001), García (2001), Torres, G.M. (2001, 2004); Martínez, C. (2001); Brito, T. (2002); Ramírez (2003), Arias, G. (2003, 2006), Moncada y Cubela (2005), Del Pino y Recarey (2006) Pérez (2007), Castro, P.L. (1990, 1996, 1999, 2004, 2008), Ferreiro (2010) y Fera (2012), Ares, P.

(1998, 2015); Pupo, R.M. (2012, 2016) los mismos coinciden en elementos básicos referenciando, que cuando la familia adquiere ciertos conocimientos y desarrolla habilidades pueden ser capaces de autorregular su función educativa.

En el diccionario enciclopédico se define como el grupo humano más importante en la vida del hombre (J Patrona, 1985); por otra parte, el Grupo Asesor Metodológico de Estudio de Familia (GAMEF) 2004, considera a esta “como grupo de personas que comparten vínculos de convivencia, consanguinidad, parentesco y afecto”.

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS) 2005, define a la familia como un grupo de dos o más personas, que conviven juntas y se relacionan unas con otras por lazos sanguíneos de matrimonio o adopción y que ejercen interacción recíproca porque saben que existen los demás y ellos se consideran como una unidad.

La autora asume el concepto dado por García G., A (2006), el cual ofrece fundamentos acordes para tratar la tartamudez en relación con la orientación familiar en la etapa preescolar, según esta autora es un “Sistema de acciones de aprendizajes desarrolladas mediante técnicas, ejercicios o procedimientos, para ser empleados dentro y fuera del momento de orientación, promovidas por la escuela que estimulen su participación activa, demostrada en su sensibilización, compromiso e implicación en la educación de sus hijos, de forma integrada”.

Desde el punto de vista pedagógico constituye un tipo de orientación con fines educativos, encaminada a elevar la preparación de padres, madres y tutores, estimulando su participación consciente en la formación de su descendencia, en coordinación con la escuela y otras instituciones sociales y hacia la prevención de la tartamudez desde el momento en que aparece el Tartaleo fisiológico.

La misión informativa y preventiva de la orientación familiar se encamina en mantener informados a los padres sobre una serie de principios pedagógicos, psicológicos, y social relacionados con la educación y el desarrollo de sus hijos; permitiendo evitar las dificultades que puedan aparecer en el proceso formativo de los mismos entre ellos los trastornos de la fluencia verbal Tartamudez.

Esta manera de orientarlos logra estrechar los vínculos entre la familia y la escuela, ya que se conjugan los esfuerzos educativos advirtiéndoles y enseñándoles cómo deben tratar determinadas situaciones de sus hijos.

A través de esta nueva vía de trabajo con la familia se promueve el apoyo de éstas en las tareas docentes educativas que se realizan en la escuela, se prepara a los padres a fin de que puedan detectar a tiempo los problemas o trastornos que puedan afectar la comunicación y el lenguaje de sus hijos.

La familia y la escuela son instituciones en las que se van logrando un mayor nivel de socialización de los escolares; ellas son nutrientes básicos de las primeras experiencias emocionales y educativas de los niños y que a la vez en su seno se les garantiza la seguridad y estabilidad necesarias para su desarrollo futuro.

Esto permite afirmar que la familia es la primera escuela y que los padres asumen el papel de los primeros maestros, al ser portadores de las primeras experiencias educativas mediante sus relaciones con el entorno social y con el legado histórico-cultural de la humanidad. De ahí, que ella sea un factor importante en la formación física, laboral y social de cada uno de sus miembros, es por ello que esa importante responsabilidad es indelegable.

Los padres deben crear y desarrollar conjuntamente con la escuela, criterios aprendidos desde la infancia, con patrones de conducta y valores morales que le permiten desarrollar en el futuro su papel con toda responsabilidad tanto en el plano afectivo como social.

En Cuba se tiene en cuenta desde la Constitución los documentos legales que permite la seguridad, oportunidad, igualdad, inclusión, desegregación, sin distinción de raza, status social, religión, los derechos del niño que desde el 20 de noviembre de 1959, en la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó y proclamó por unanimidad. El niño gozará de una protección especial y dispondrá de oportunidades y servicios, dispensado todo ello por la ley y por otros medios, para que pueda desarrollarse física, mental, moral, espiritual y socialmente en forma saludable y normal, así como en condiciones de libertad y dignidad, la familia es la célula elemental de la sociedad pues contribuye al desarrollo de la misma y cumple importantes funciones en la formación de las nuevas generaciones, es por ello que debe estar orientada a atender de forma exitosa y con un carácter preventivo la Tartamudez desde la etapa preescolar.

1.2 La prevención de la tartamudez en la etapa preescolar. Un reto para la familia

La concepción de prevención ha transitado por diferentes momentos en el proceso del desarrollo de las ciencias que se ocupan del estudio del hombre así como varios son los autores que lo han abordado entre los que se encuentran, (De Mercer, C; 1991). (Bell, R. 1995), (Pérez, E. y otros. 1996), E. Figueredo (1996), R. López Machín (2000), El MINED (2000), González (2005), Betancourt y González (2005), La UNESCO, 2007, los cuales confluyen en aspectos comunes que la identifican en la anticipación, previsión y actuación oportuna para evitar que se produzcan dificultades, problemas y trastornos que entorpezcan el armónico y normal desarrollo de la personalidad.

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS) 1996 plantea que la prevención es una práctica permanente de educación, respeto, estímulo y normas que conducen a definir un estilo de vida, basado en la libertad y el crecimiento personal. Esta definición no puntualiza el carácter sistémico y sistemático de las acciones que se realizan, atendiendo a las características de los diferentes contextos y grupos humanos. La definición de la OMS introduce aspectos importantes a tener en cuenta en la concepción del trabajo preventivo tales como: calidad de vida, estilos de vida y crecimiento personal entre otros. Es significativo en este aspecto que la educación debe crear condiciones para que su más joven producto logre el desarrollo de una vida sana, plena y que esté en condiciones de realizar una inserción a la sociedad que le permita crecer personal y profesionalmente. En la definición se reconoce también la participación de la comunidad, aunque no se enfatiza en la importancia de las acciones preventivas en el ámbito familiar.

Resulta pertinente adoptar una posición con relación al concepto de prevención desde el proceso pedagógico.

La prevención primaria es evitar que el impedimento o trastorno ocurra y la prevención secundaria es evitar que una vez ocurrida se convierta en una limitación permanente. (Bell, R. 1995)

La escuela cubana le confiere a la prevención un alcance mayor y la convierte en el centro de un estilo pedagógico que trasciende la Educación Especial. Se concibe como un sistema integral de influencias que ha de anticiparse a las posibles dificultades que puedan surgir en el proceso pedagógico y contempla la integración de todo el sistema educativo, en primer lugar de la educación infantil.

La autora asume la definición dada por Betancourt y González (2005) las mismas destacan que la prevención es una dimensión de la actividad educativa que implica la actuación oportuna de los docentes para promover el desarrollo y estimular potencialidades. Las autoras introducen un aspecto que desde el punto de vista metodológico permite una mejor organización de las acciones preventivas, con la participación de la familia y los agentes de la comunidad, no es una actividad independiente, sino que forma parte de la labor docente diaria, en aras de lograr el máximo desarrollo de las potencialidades. Las autoras analizan la importancia de establecer teórica y metodológicamente, que existe una relación dialéctica entre prevención, diagnóstico y estimulación para el desarrollo pleno de las personalidades en formación.

Una forma para la prevención en el proceso pedagógico, es desde los postulados de la estimulación temprana y el papel rector de la familia: “el hogar es la primera escuela del niño y los padres sus primeros maestros, por lo que es necesario aprender a educar a los hijos” (Para la vida, 1992, p.2) y “los padres... necesitan ayuda para cumplir su papel”. (De Mercer, C; 1991). Una vía para avizorar el surgimiento de un problema en el desarrollo es el control del riesgo.

Según Tjossem y Lorenzo que consideran tres tipos de riesgo: el establecido, el biológico y el ambiental, como “cierto atributo o característica que le confiere al individuo un grado variable de susceptibilidad para contraer la enfermedad o alteración de salud”. (C. A, MINSAP)

La aparición de uno de estos factores no significa que sea inminente la aparición del trastorno, pues lo más común es que sea resultado de la concurrencia de varios de ellos, su presencia solo implica una probabilidad mayor respecto al resto de la población infantil.

Esta particularidad adquiere relevancia en la tartamudez pues al vincularse su origen con una multicausalidad de factores, (sin la certeza de cual la determina), su prevención es posible a partir de la identificación del riesgo y para identificar el riesgo es imprescindible definir los factores que le originan.

En este trabajo se adoptaron a partir de las causales más referenciadas en la literatura y las más frecuentes en la población investigada. (Pérez, E. y otros. 1996) El momento idóneo para detectar cuáles niñas y niños tienen riesgo de desarrollar una tartamudez es entre el segundo y tercer año de vida, antes que inicie el período de disfluencia verbal.

Las personas indicadas para detectar la población en riesgo son los padres, el médico de la familia y los educadores (ejecutora o educadora del C.I). Esta última ocupa un lugar privilegiada por la labor educativa que desarrolla en el C.I y las vías no formales (V.N.F), por tanto es la más indicada para dirigir este proceso. Para desarrollar la prevención primaria de la tartamudez son requisitos:

- Definir el momento adecuado.
- Exista la oportunidad real.
- Lograr el compromiso de la familia.
- Organizar el sistema de influencias a partir de la actividad fundamental.

La definición de las etapas para la prevención siguió un camino sencillo. En la prevención primaria preparar a la familia con conocimientos sólidos para conducir el desarrollo general y verbal y después consolidar esos logros. En la prevención secundaria preparar las condiciones que permitan superar las dificultades verbales y psicológicas, para después propiciar la integración escolar y social.

La tartamudez es un trastorno en el habla difícil de superar por lo tanto es necesario concebir la corrección desde una perspectiva diferente. Al estudiar la definición de Fernández, G. (20002, p.51) sobre corrección en la tartamudez, se aprecia que la concepción de prevención secundaria tiene un alcance diferente, en armonía con posiciones pedagógicas positivas, de no violentar el equilibrio personal, por lo que resulta más optimista concebir la ayuda con un carácter preventivo.

Desde la ciencia la evolución histórica del trastorno ha transitado por profundas revelaciones las cuales se determinan dado los diferentes criterios acerca de

los trastornos de la comunicación oral; la tartamudez se considera como una alteración del ritmo y la fluidez verbal. A pesar de ello se le designa con términos diversos como: disfemia, espasmofemia, tartamudeo, balbuceo, laloneurosis.

Diferentes son los autores que han conceptualizado a la tartamudez entre sus principales exponentes se encuentran, Castellanos J. (1921), (Van Riper, 1951,1978); Johnson, 1959; Seeman, 1959, (Liapidievski, 1970); (Perelló J, 1973); (Cabanas, R, 1973); (Figueredo, E. 1984) (Picchon, E.1980 y Maisonnny, S. 1989), (Fernández, G, 1989) (Santacreu 1991), (Biaint de Touzet 1991) ;(Irwin A. 1992) (Fernández, G, 2002) en ellos se destaca la interpretación de la tartamudez por la relación de factores personales y ambientales o trastorno neuropsicológico.

La autora asume la definición dada por (Fernández, G. 2002). Es un trastorno complejo de la comunicación oral, caracterizado por espasmos que interrumpen la fluidez verbal, acompañado de síntomas orales y psicopatológicos, de naturaleza multicausal, que afecta los mecanismos de control del habla, la comunicación y la personalidad.

Varias han sido las interpretaciones de diferentes investigadores sobre los factores causales de la tartamudez, se ha enfocado desde diversos ángulos donde se atribuye el fenómeno a causas muy variadas como: mal formaciones de los órganos fonadores, anomalías de zonas y funciones cerebrales vinculada al lenguaje, predisposición hereditaria, factores psicopatológicos centrados en la influencia de la educación familiar y factores ambientales diversos. La mayoría de los autores coinciden, en que una serie de factores en relación directa con las particularidades del desarrollo del lenguaje en el escolar pueden dar lugar al surgimiento de la tartamudez.

El Dr. H Gregory (1991) describe tres principios básicos del surgimiento de la tartamudez.

- Factores predisponentes: las variables del medio interactúan con la predisposición hereditaria y pueden dar como resultado la aparición de la tartamudez.
- Factores desencadenantes: son los que se relacionan con las tenciones producidas por el medio.

- El mantenimiento: depende de la estructura psíquica de la persona. En dependencia de las características de la estructura psíquica y dependiendo de la evolución del tratamiento, se hará necesario o no un tratamiento psicológico.

Este análisis permite considerar que la tartamudez actualmente se ha enfatizado en: predisposición hereditaria, factores psicológicos, factores ambientales diversos, fenómenos afectivos, relaciones familiares distorsionadas, severidad de una educación perfeccionista entre otras.

En las primeras edades alrededor de los tres años se produce un proceso de integración ideo verbal en los niños (Cabanas. R 1973) con presencia de titubeos, vacilaciones y repeticiones inconscientes e involuntarias por lo que la afectación es de forma inconsciente, identificándose el primer nivel de afectación inconsciente.

Cuando ya el modelo lingüístico no es el esperado por el niño, ni por el medio que lo rodea: sus padres, el proceso de retroalimentación del medio hacia él acerca su forma de hablar y la de sí mismo al escucharse y compararse con los demás, se conduce a la concientización de la dificultad por lo que la afectación pasa hacer consciente.

Una vez que surgen los espasmos y se hacen consciente, el niño trata de enmascarar el trastorno ante determinadas situaciones comunicativas a través de una ejecución voluntaria de la forma de hablar y por tanto se pierde el automatismo y espontaneidad del habla, se produce un rompimiento entre los sistema de dirección voluntaria e involuntaria del paso del programa verbal a la fase de su enunciado externo, lo que se identifica como segundo nivel de afectación consciente y, por último, se instala la tartamudez afectándose la comunicación oral y el desarrollo de la personalidad, para un tercer nivel de afectación consiente. Por lo que se deduce que la tartamudez transcurre desde el plano inconsciente al consciente.

Los estudios realizados por Pérez E. (2002) describen las características de las personas tartamudas con la que se coincide en esta investigación.

- ✓ Contracciones espasmoideas entendida como el signo externo principal y pueden ser de tipo clónico, tónico y mixto, de alta frecuencia y altamente vivenciales.

- ✓ Alteraciones en el ritmo y la fluidez verbal provocada por la ausencia de sincronismo entre los diferentes tiempos articulatorios que alteran la línea melódica de la frase.
- ✓ Movimientos auxiliares se manifiestan de forma involuntaria al irradiarse las contracciones a los músculos colaterales o voluntarios como mecanismo de defensa para estimular el lenguaje y enmascarar el trastorno.
- ✓ Alteraciones respiratorias producidas generalmente a consecuencia del espasmo o recurso de ayuda que al fijarse se automatizan.
- ✓ Alteraciones psicológicas dadas por inseguridad, baja autoestima, sentimientos de minusvalía, dificultades en las relaciones interpersonales y sufrimiento del defecto.
- ✓ Logofobia: es el temor a hablar que se extiende a diferentes aspectos de la comunicación y esferas de la vida, expresa el grado de severidad y unifica las dos áreas de la personalidad básicamente afectadas, la psicológica y la verbal.

Esta clasificación diferencia entre tartamudez **tónica** (espástica o abierta) y **clónica** (cerrada).

- **Tartamudez Tónica:** Inmovilización muscular fonatoria, seguida de una explosión cuando la inmovilización cede. Son los bloqueos o espasmos, aunque estos términos también se usan como sinónimos de difluencia.
- **Tartamudez Clónica:** Repetición de sílabas o palabras incontrolada, pero son contracciones anormales de los órganos.
- **Tartamudez mixta:** se llaman tónico-clónicas y clónico-tónicas. Se supone que tiene peor pronóstico las que tienen más componente tónico (peor la tónico que la clónica y peor la tónico-clónica que las clónico-tónicas).

Autores como (Quirós, J; Cowes, L y Schrager, O. 1978) señalan que no es casual que la tartamudez se instale en períodos sensitivos del desarrollo, en los que ocurren verdaderas revoluciones del S.N.C que constituyen jalones importantes del desarrollo humano.

En la etapa preescolar, a los tres años, que marca la relación pensamiento - lenguaje. En la etapa escolar temprana, a los seis años, con el paso al pensamiento pseudoconceptual o empírico, a los nueve años, con el establecimiento de la dominancia hemisférica y en la adolescencia, con el paso al pensamiento teórico. Todo ello en relación con el proceso de formación del lenguaje y la reestructuración anatomofisiológica del cerebro que ello implica, con su respectiva carga neuroendocrina y afectivo-emocional, en vínculo con las situaciones comunicativas, estudios más avanzados de las neurociencias plantean que la tartamudez tiene una base genética a partir de la identificación del Gen 14pzt263.

Es importante señalar la influencia que ejerce la familia en la aparición de estas sintomatología al no tratar adecuadamente la aparición del tartaleo fisiológico y por ello la falta de orientación para su prevención.

1.3 La etapa preescolar en el desarrollo del lenguaje

El conocimiento de la importancia de la infancia como punto de partida de los seres humanos para comprender la necesidad de destinar esfuerzos para brindar a los niños el mejor entorno para su desarrollo. La niñez también es la etapa más importante porque ahí es que se crea tu cuerpo tu forma de ser aunque algunas veces puede ser genético.

En Cuba se reconocen los trabajos de: J. Pascual (1988), F. Domínguez (1990), L. F. Herrera (1992), N. del Rosario (1993), G. Arias (1994), C. Viñals (1995), R. Padierno (1996), H. Gómez (1997), K. Alvarado (1998), J. Solano (1998) en la detección y estimulación temprana de los lactantes básicamente de alto riesgo; así como los de F. Martínez (1983), M. Manzano y colaboradores (1989), M. López, (1998), E. Olivera (2001), C. Zurita (2003). N. de la Peña (2004) G. Fernández y colaboradores (2003), V. Ramírez (2005), F. Huepp (2006) y un grupo de especialistas del Ministerio de Educación que trabajan de manera coordinada con las instituciones pediátricas de salud y el médico de la familia para estimular tempranamente a los niños con características especiales en el desarrollo que asisten o no al círculo infantil.

De ahí que la autora asume la siguiente definición *la Etapa preescolar* (de tres a seis años) “etapa en la que comienza a percibirse una diferenciación

sustancial, otro tipo de relación con los coetáneos y otras actividades que le proporcionan satisfacción y desarrollo (entre las que se destaca el juego)".¹

La etapa preescolar se concibe como etapa ideal, privilegiada y de mayores oportunidades y posibilidades para el desarrollo humano. La educación debe ser oportuna y pertinente desde la edad más temprana para que desarrolle las capacidades para el aprendizaje y propicie el proceso de culturalización y socialización del niño y el carácter diferenciado e individual del proceso educativo.

Entre los beneficios de la atención preescolar vale destacar:

Que los padres se desempeñan con máxima eficacia y autonomía en la educación de sus hijos y los niños desarrollan al máximo sus capacidades por lo que se minimizan o corrigen los efectos de los factores de riesgo biológico y/o social y se evita la aparición de dificultades del nivel secundario y terciario por lo que se debe ofrecer una atención oportuna a las demandas del niño.

- **Particularidades de la etapa preescolar**

Una particularidad importante del 3er año de vida consiste en que hacia su final ya están presentes todas o la gran mayoría de las estructuras básicas de la lengua, por lo que lo hace un año de especial significación a los fines del desarrollo del lenguaje. La explosión del lenguaje, característica del año de vida anterior, permite una mayor ampliación del vocabulario, con presencia de oraciones compuestas más complejas, y que van a determinar la posibilidad de una mayor expresión oral y una comunicación más amplia. El análisis comparativo de estos dos años de vida en su conjunto, nos permite afirmar que el periodo sensitivo del lenguaje se enmarca en esta etapa, desde su manifestación primigenia en la explosión del lenguaje hasta la asimilación de las estructuras básicas de la lengua.

Quinto año

1. Este año de vida es de transición en el desarrollo del lenguaje en la edad preescolar, pues generalmente se destaca en una mayor complejidad de la estructura básica ya adquiridas, o una mayor calidad de los logros previamente manifestados, como sucede con la conversación del tipo contextual, siendo su

¹ Ríos Leonard: "Fundamentos científicos de la Educación Preescolar", en: *Compendio de trabajos de posgrado. Educación Preescolar*, p. 104.

principal y significativo aporte al surgimiento del lenguaje interno, no observable objetivamente en el año precedente.

Surgimiento del lenguaje para sí, y del lenguaje interno.

La presencia del lenguaje para así, probablemente como primera manifestación del lenguaje interno y se observa principalmente en la realización de las tareas cognoscitivas en las que el niño se concentra profundamente y con cierta frecuencia emite expresiones audibles y sonidos bajos dirigido a la acción que efectúa, señalamiento en otras ocasiones, se concretan en micro movimientos de los labios. Este comportamiento marca un paso importante en el desarrollo del lenguaje, y caracteriza a los niños de este año de vida pues el anterior año de vida de existir, no era perceptible objetivamente al observado.

2. Consolidación del tiempo presente y uso del pasado en oraciones combinadas, subordinadas y compuestas de corta extensión. El mayor dominio de la lengua materna permite la utilización de frases combinadas, subordinadas o compuestas en estos casos temporales entre otras, que reflejan la mayor calidad entre este logro, presente desde el año anterior.

3. Conversación contextual de corta extensión, sin grandes complicaciones gramaticales, morfológicas o sintácticas. Las posibilidades de expresión hacen posible la realización de conversaciones cuyo contenido esta fuera de la situación contextual, de manera ya habitual, pero de cortas extensión y muy relacionas aun con las propias vivencias, sin uso de expresiones verbales gramaticalmente muy complejas

4. Identificación propia bien diferenciada, uso del nombre y un apellido. La propia identificación es plena, incluso cuando es referencia en tercera persona. El reconocimiento de los demás esta fundamentalmente determinado por los nexos familiares y sociales. En cuanto a los adultos, sin que el niño domine sus nombres incluyendo a los padres, la identificación de los iguales está bien definida.

Sexto año

Este año de vida constituye un perfeccionamiento de las estructuras previamente formadas, la consolidación de los logros alcanzados y su complejizarían, así como la completa asimilación de las reglas gramaticales, por las que el niño se guía al hablar. Desde este punto de vista, salvo la asimilación del lenguaje escrito como tal, todas las estructuras fundamentales de la lengua materna están conformadas y consolidadas, y en este sentido el habla del niño preescolar a los seis años solo se diferencia del adulto en su contenido y, naturalmente, en un menor desarrollo de su lenguaje lógico, lo cual está determinado, por supuesto, por el surgimiento del pensamiento lógico-verbal, que se ha de perfeccionar en la edad escolar y adolescente.

1. Enriquecimiento del lenguaje interno.
2. Asimilación de los tiempos fundamentales, pasado-presente-futuro, con complejidades gramaticales, y secuencia y diferenciación de acciones temporales.
3. Aparición del sentido de la lengua, generalizaciones idiomáticas empíricas y de carácter no consciente.
4. Conversación contextual compleja.
5. Verbalización del establecimiento de relaciones causa-efecto complejas.
6. Identificación propia bien consolidada, y de los demás respecto a sí, uso de nombre y dos apellidos.

Logros del desarrollo del lenguaje (4-5 años):

- Dominan las estructuras básicas de la lengua natal, así como su apropiada articulación. Dialogan con expresión correcta.
- Expresan y describen de forma bastante coherente hechos sociales, acontecimientos, cuentos o relatos en pasado y presente.

Objetivos y logros del desarrollo del lenguaje (5-6 años)

- Evidenciar el dominio práctico de su lengua materna al:
- Utilizar un vocabulario amplio relacionado con los objetivos del mundo en que interactúa. Pronunciar correctamente los sonidos del idioma.
- Expresarse con claridad, fluidez y coherencia acerca de los hechos y experiencias sencillas de su vida cotidiana y de las cosas que aprende.
- Sentir gusto y satisfacción al utilizar las distintas formas bellas del lenguaje literario.

Logros del desarrollo del lenguaje del sexto año de vida (5-6 años):

- El niño expresa sus ideas y deseos de forma intencionalmente clara, siguiendo un orden lógico.
- Pronuncia correctamente todos los sonidos de la lengua.
- Realiza el análisis de los sonidos que comprende la palabra.
- Se expresa de manera adecuada, siguiendo las reglas gramaticales, en presente, pasado y futuro, aunque le den niños que transformen la letra o la canten incompleta. Este se relaciona con la dificultad absoluta de describir.
- Verbalización del establecimiento incipiente de la relación causa-efecto, Surgimiento de los porqués de tipo cognoscitivo, directos.
- Conversación del tipo situacional, con elementos contextuales, fundamentalmente relacionado con vivencias personales. La ampliación del vocabulario, la posibilidad de extensión temporal y de relatar vivencias.
- Uso apropiado de las relaciones de lugar, no así de las temporales. La mayoría de los adverbio de lugar son utilizados de manera correcta por el niño, aunque algunos no sean totalmente dominados, aunque usa palabras que designan relaciones temporales.
- Identificación y diferenciación por su nombre propio, agrega un apellido ante la pregunta del adulto. En este año el niño se identifica directa o indirectamente por su nombre, mas generalmente requiere de la pregunta del adulto. La mayoría conoce su edad expresándolo con los dedos.

Vocabulario

En esta etapa la evolución del lenguaje juega un papel importante, la estructuración y desarrollo del componente léxico-semántico, es decir, el

vocabulario del niño. Para el análisis de este componente es necesario tener en cuenta el llamado vocabulario pasivo (palabras que el niño conoce pero que no utiliza durante su expresión) y el vocabulario activo (palabras que utiliza durante el acto verbal de forma libre y espontánea). En el niño del sexto año debe ser posible, como resultado de todo el sistema de influencias educativas y particularmente de la Lengua Materna, su expresión oral de manera fluida y coherente, en la que los vocablos utilizados se correspondan de forma adecuada con el objeto, ideas o fenómenos que designan, y que las palabras que conoce en su vocabulario .pasivo, se expresen de manera activa, de acuerdo con la situación específica. Desde este punto de vista, el trabajo con el vocabulario no solamente se dirige a la comprensión y utilización de nuevos términos, sino a formar una actitud consciente hacia la palabra, y enriquecer su amplitud con la inclusión de adjetivos, adverbios, verbos y sustantivos que tengan carácter generalizador de la expresión oral.

Por todo lo anteriormente expuesto es por ello que se hace necesario desde las diferentes ciencias entre ellas la Logopedia, centrar los estudios en la orientación familiar, y a partir de ella desplegar acciones teórico metodológica que contribuyan a prevenir la tartamudez en la etapa preescolar.

CAPÍTULO II: CARACTERIZACIÓN DEL ESTADO ACTUAL DE LA ORIENTACIÓN FAMILIAR PARA LA PREVENCIÓN DE LA TARTAMUDEZ EN LA ETAPA PREESCOLAR

En este capítulo se realiza la operacionalización de la variable, el análisis de los resultados obtenidos en la aplicación de los instrumentos y se fundamenta el

folleto de orientación familiar para la prevención de la tartamudez en la etapa preescolar, su estructura y se valoran los resultados obtenidos mediante la realización del test de satisfacción familiar.

2.1 Operacionalización de la variable

A partir de la sistematización de los referentes teóricos metodológicos autores como: García, A (2001- 2011), Ramírez (2003) Moncada y Cubela (2005), Del Pino y Recarey (2006) Pérez (2007), Ferreiro (2010) y Fera (2012); Ares, P. (1998, 2015); Torres, G.M. (2001, 2004); Martínez, C. (2001); Brito, T. (2002); Arias, G. (2003, 2006), Pupo, R.M. (2012, 2016) acerca de los estudios de la familia y su orientación educativa y de la experiencia en la práctica laboral se pudo realizar la siguiente operacionalización de la variable principal de la investigación: **la orientación familiar para la prevención de la tartamudez en la etapa preescolar** como:... "Un sistema de acciones de aprendizaje dirigidas a la familia para la actuación oportuna y prevención de la tartamudez en educandos de la etapa preescolar"...²Es por ello que a partir de esta definición se determinan los indicadores para el estudio del estado inicial del problema científico y su posible solución. **(Ver anexo (1)).**

Los indicadores para medir el estado inicial y el deseado son:

- I. Nivel de conocimiento de las familias sobre el período de difluencia verbal (tartaleo fisiológico) y la tartamudez.**
- II. Nivel de conocimiento de las familias sobre los factores de riesgo para el surgimiento de la tartamudez.**
- III. Frecuencia de orientación familiar sobre la prevención de la tartamudez en la etapa preescolar.**
- IV. Nivel de conocimiento de acciones para prevenir la tartamudez.**

Caracterización del grupo de estudio.

Se tomaron como grupo de estudio 5 escolares de ellos 2 comprendidos en las edades de 3 y 4 años y 3 de 5 años que se encuentran en el grado preescolar asistiendo a la escuela Néstor de Aranguren donde la autora realiza las prácticas pedagógicas.

² Operacionalización del término. Bárbara Cobo Valdés. 2019

En los resultados de la exploración logopédica inicial (**anexo 5**) se constató como diagnóstico logopédico que los 5 educandos transitan por la etapa de tartaleo fisiológico. De origen multicausal debido al mal manejo familiar y la escasa estimulación del lenguaje por estos, los inadecuados patrones verbales y la existencia de familiares cercanos y vecinos con tartamudez, en las 5 familias del grupo de estudio hay presencia del trastorno por parte de sus miembros, 2 padres y un tío, la mayoría son familias disfuncionales que no tienen estudios universitarios y muchos de sus miembros no alcanzan ni el 12 grado las mismas están insertadas en la comunidad **Los Bulevares** en Guanabo el cual es un Consejo Popular del municipio Habana del Este limita al norte con el estrecho de la Florida, al este con el municipio de Santa Cruz del Norte (Provincia Mayabeque), al sur con el Consejo Popular de Campo Florido, al oeste con el reparto Boca Ciega.

Esta comunidad está constituida aproximadamente por 3000 personas, como principales puntos de interés encontramos la escuela primaria Néstor Aranguren y una unidad militar, además de contar con un consultorio médico, en cuanto al patrón verbal que predomina en la comunidad se evidenció que la mayoría practica patrones incorrectos del lenguaje.

2.2 Análisis de los Instrumentos aplicados en la investigación

- **Indicador I: Nivel de conocimiento de las familias sobre el período de disfluencia verbal (tartaleo fisiológico) y la tartamudez**

Para evaluar este indicador fue necesario aplicar una guía de entrevista a padres (**anexo3**). En la cual se evaluó de medio para el 20% de las familias ya que

conocen aspectos aislados sobre el período de disfluencia verbal, a qué edad se manifiesta y algunas de sus características principales, no así en las 4 familias restantes para un 80% de bajo conocimientos sobre esta etapa pues se refieren al trastorno como "gagera" y alegan que este no tiene relación alguna con la tartamudez, además refieren no saber qué acciones se pueden realizar con el niño que presenta tartaleo fisiológico para evitar el surgimiento de la tartamudez, no obstante les interesa ampliar sus conocimientos para poder brindar una mejor atención y ayuda oportuna a las necesidades de sus hijos.

- **Indicador II: Nivel de conocimiento de las familias sobre los factores de riesgo para el surgimiento de la tartamudez**

Para el estudio de este indicador se realizó la guía de entrevista a padres (**anexo 3**) en la cual se evaluó de alto para el 10% de las familias, medio para el 10% y bajo en el 80% restante pues poseen insuficientes conocimientos sobre el desarrollo del lenguaje y las etapas por las que transita, cuándo debe comenzar el gorjeo, balbuceo, vocalizaciones, la aparición progresiva de frases estereotipadas hasta llegar al lenguaje propiamente dicho así como su importancia para brindar una correcta estimulación temprana a sus hijos, no conocen acciones que se pueden llevar a cabo en la etapa de tartaleo fisiológico para prevenir el surgimiento de la tartamudez y que una rigidez en la educación familiar, expresada en exigencias verbales y comportamentales pueden incidir en el lenguaje del niño.

- **Indicador III: Frecuencia de orientación familiar sobre la prevención de la tartamudez en la etapa preescolar**

En este indicador se aplicó como instrumento la guía de entrevista a padres y la encuesta a docentes y directivos de la escuela en la cual se tomaron como muestra a 5 familias y 5 directivos de la escuela (**anexo 3 y anexo 6**) fue evaluado de siempre para el 20%, casi siempre para 20% y casi nunca par el

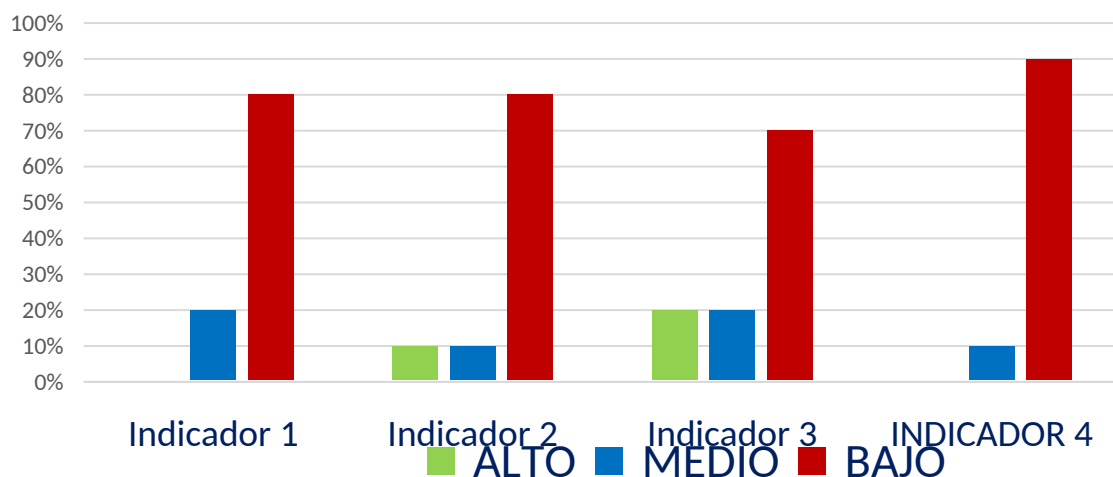
60% a partir de ello se pudo constatar que las familias carecen de conocimientos sobre cómo prevenir, corregir y/o compensar el trastorno logopédico pues utilizan inadecuadas conductas y patrones verbales con el educando, hay insuficiencias en los programas preventivos y orientadores en la escuela cómo lo es el programa Educa a tu hijo ya que la mayoría de las veces los padres no asisten o no se realiza, son insuficientes las orientaciones que recibe la familia para estimular el lenguaje de los niños y no se realizan acciones para la prevención de la tartamudez en la etapa preescolar.

- **Indicador IV: Nivel de conocimiento de acciones para prevenir la tartamudez**

Para el análisis de este indicador se realizó la guía de entrevista a padres y la guía de observación a la familia (**anexo3 y 4**) fue evaluado de medio para el 10% de las familias y bajo para el 90% de estas pues poseen insuficientes conocimientos sobre cómo se desarrolla el lenguaje y las etapas por las que transita, no saben qué actividades realizar con el niño para estimular su lenguaje para brindarle una mejor atención a sus necesidades comunicativas.

Se precisó que la función estimuladora del lenguaje en estas familias se ve afectadas porque los adultos creen más cómodo para el niño el uso de palabras inventadas, 60% se anticipan a los deseos del niño sin darle oportunidad de expresarse oralmente, usando el habla aniñada en su trato afectivo con el infante, el adulto utiliza una lengua simplificada que generalmente usa tercera persona, con énfasis en la utilización de onomatopeyas, y uso frecuente de diminutivos además admiten que sus hijos usen gestos, señas o toquen lo que desean para adquirirlo sin exigirles que se comuniquen oralmente, sin embargo se muestran cooperadores con el proyecto y durante la aplicación de la encuesta el ambiente que predominó fue cooperador e interesado en las actividades.

Resultados del diagnóstico inicial:



Se relacionan a continuación las **fortalezas** y **debilidades** resultantes de la aplicación de los instrumentos:

- Mediante la aplicación de los instrumentos se encontraron como principales **debilidades** que las familias poseen insuficientes conocimientos sobre cómo se desarrolla el lenguaje y las etapas por las que transita.
- Se precisó que la función estimuladora del lenguaje en estas familias se ve afectadas porque los adultos creen más cómodo para el niño el uso de palabras inventadas y el habla aniñada.
- Admiten que sus hijos utilicen gestos, señas o toquen lo que desean para adquirirlo sin exigirles que se comuniquen oralmente.
- En su trato con el niño se evidencian conductas inadecuadas ya que presionan a este para que pronuncie bien las palabras y para que su habla discurra normalmente, esto mediante fuertes gritos y "agitones".
- Desconocen que actividades se pueden realizar con el niño que presenta tartaleo fisiológico para evitar el surgimiento de la tartamudez.
- Se desarrollan inadecuadamente programas preventivos y orientadores en la escuela cómo lo es el programa Educa a tu hijo ya que la mayoría de las veces los padres no asisten o no se realiza.

Se encontraron como principales **fortalezas**:

- Existen conductas potenciadoras que pueden ser provechosas para trabajar con la familia ya que se muestran interesados en el tema y

como ampliar más sus conocimientos sobre la prevención de la tartamudez para poder brindar una mejor atención y ayuda oportuna a las necesidades de sus hijos.

- Durante la aplicación de los instrumentos el ambiente que predominó fue cooperador e interesado en las actividades.

El análisis bibliográfico realizado por la autora y los resultados de los diferentes instrumentos aplicados propician que se proponga como solución al problema de investigación un folleto de orientación familiar para la prevención de la tartamudez en la etapa preescolar.

2.3 Fundamentación teórica metodológica de la propuesta de un folleto de orientación familiar para la prevención de la tartamudez en la etapa preescolar

Teniendo en cuenta lo anterior se determinan los aspectos teóricos planteados que sustentan y se asume desde el enfoque histórico - cultural los fundamentos filosóficos, psicológicos, logopédicos, sociológicos, biológicos, pedagógicos y didácticos para elaborar un folleto de orientación familiar para la prevención de la tartamudez en la etapa preescolar. Se toma como referencia el enfoque Vigotskiano, en el cual los pequeños deben lograr un papel activo en el proceso educativo, posibilitando de esta forma un aprendizaje desarrollador y una mayor preparación para la vida, el trabajo con las familias la cual se sustenta en el papel que tiene la educación para alcanzar la educabilidad de toda la sociedad y esta se convierte en una escuela, se aborda el carácter integral de la educación que contempla no solo la adquisición de conocimientos sino también la ampliación de la cultura.

En la propuesta se establece la unidad de lo instructivo, educativo y desarrollador, al favorecer los intereses de las familias y la comunidad, elevando el nivel de exigencia de estos agentes mediante su valor práctico e individual que se establece en el momento de brindar una correcta orientación hacia la estimulación de todos los procesos por los que va transitando el escolar, así como el principio del carácter colectivo e individual de la educación. Se fundamentan en los principios de la didáctica ya que tienen en cuenta en su elaboración y ejecución la utilización de los componentes del proceso docente educativo tanto personales como no personales. Se fundamentan en los

principios psicológico ya que parten de las ideas básicas que determinan el nacimiento de los programas de orientación surgen tanto de la psicología evolutiva y del desarrollo. En la investigación se evidencia la relación entre lo biológico, psicológico y lo social al tener en cuenta las particularidades de los escolares con tartamudez, el papel activo de la familia y la comunidad como principales mediadores del proceso de enseñanza aprendizaje.

Este folleto tiene como objetivo orientar a la familia sobre los factores de riesgo, la conducta y acciones a realizar con el niño para prevenir la aparición del trastorno que le será de utilidad a toda la familia cubana por la influencia del trastorno y el desconocimiento de muchos a cerca de la tartamudez y cómo prevenir su aparición o establecimiento.

2.3.1 Folleto de Orientación familiar para la prevención de la tartamudez en la etapa preescolar

Un folleto es lo mismo que un tríptico, un texto impreso reducido de hojas, que sirve como instrumento divulgativo o publicitario.

En marketing, el folleto también es una forma sencilla de dar publicidad a una compañía, producto o servicio. Su forma de distribución es normalmente variada: situándolo en el propio punto de venta, mediante envío por correo o buzoneo o incluyéndolo dentro de otra publicación de venta o entre otras cosas.

Un panfleto es un escrito breve. Por extensión se emplea para escritos de propaganda. No contiene las connotaciones negativas del español y se traduce más correctamente como folleto.

Su formato original, así como el más habitual, es la octavilla, por su fácil impresión, su bajo costo y su rápida difusión.

Con la aplicabilidad del folleto se abordará de manera detallada y sencilla los procedimientos a seguir por la familia para evitar la aparición o establecimiento de la tartamudez.

DRAE

2.3.2 Estructura y características del folleto de orientación familiar.

El folleto de orientación familiar para la prevención de la tartamudez consta de 13 páginas distribuidas en presentación, índice, introducción, desarrollo, conclusiones.

En la introducción se aborda la intencionalidad del folleto y un breve resumen del contenido del folleto, en el desarrollo se abordan los factores de riesgo para el surgimiento de la tartamudez, un resumen sobre la ontogénesis del lenguaje para ampliar el conocimiento familiar sobre las diferentes etapas por las que transita este, así como algunas de las características principales que nos ayudan a identificar al niño cuando está en la etapa de tartaleo fisiológico para poder realizar una mejor labor de prevención, y las orientaciones a los padres de educandos que transitan por esta etapa, por último en las conclusiones se expresa la finalidad de este.

Este folleto se debe encontrar disponible en la escuela primaria Néstor Aranguren donde Educadores del programa Educa a tu hijo, educadores de círculo infantil demás maestros, agentes y agencias comunitarias serán los encargados de promover la importancias de su uso en las familias y que estos se sientan lo suficientemente orientados sobre cómo prevenir la aparición o establecimiento de la tartamudez en la etapa preescolar.

2.3.3 Orientaciones Metodológicas que se deben cumplir para la aplicación del folleto:

- Desarrollarse en un medio alegre y estimulante
- Deben realizarse acorde a las características individuales de cada familia.
- Tener una parte inicial que garantice las condiciones previas para su presentación, una adecuada orientación hacia los objetivos, desarrollo de las orientaciones y conclusiones.
- Que el medio en que se desarrolle acepte la realización de acciones de carácter preventivo.
- Que se tomen como referencias las anotaciones en cada acción de orientación que se realicen en la escuela y el coordinador del Programa Educa a tu Hijo.
- La comunidad donde se encuentra insertada la escuela, con sus agencias y agentes comunitarios deben ser potenciadores de buenas prácticas en el desarrollo de habilidades comunicativas para el uso adecuado de la lengua materna la cual debe desarrollarse en un ambiente de reflexión, debate, aceptación individual y colectiva asertiva hacia la inclusión socio educativa de las personas diversas.
- Las acciones que se realicen en coordinación con los factores comunitarios deben tener una mirada intersectorial en función de la prevención del trastorno y el desarrollo local para la Tarea Vida (Escuela, familia, comunidad).

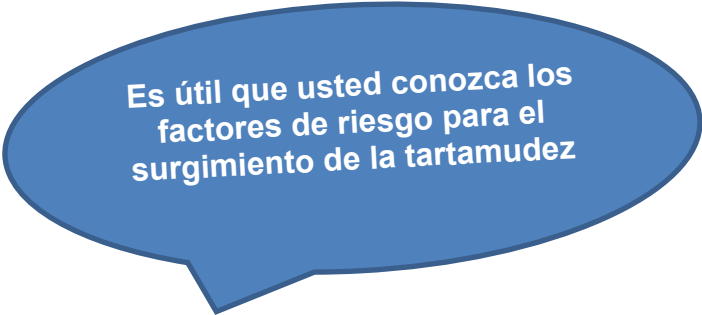
Estructura y contenido de la propuesta

A continuación se presenta el folleto de orientación familiar para la prevención de la tartamudez en la etapa preescolar el cual se fundamenta en los referentes

teóricos abordados en el capítulo 1, en el diagnóstico del estado inicial y en los fundamentos tratados con anterioridad.

Objetivo general: Orientar a las familias para la prevención de la tartamudez en la etapa preescolar.

Desarrollo



Es útil que usted conozca los factores de riesgo para el surgimiento de la tartamudez

- ★ Antecedentes familiares de tartamudez u otros trastornos relacionados con la comunicación
(mentales y de aprendizaje).
 - ❖ Frecuencia de aparición.
 - ❖ Convivencia con esas personas
- ★ Enfermedades que incidan en la formación del sistema funcional verbal.
 - ❖ Enfermedades respiratorias frecuentes.
 - ❖ Enfermedades que por su frecuencia o intensidad debilitan el organismo
- Insuficiente conocimiento de la ontogenia verbal por familia y educadores.
- ★
 - ❖ Etapas de desarrollo del lenguaje.
 - ❖ Período de disfluencia verbal.
 - ❖ Dificultades y trastornos verbales más frecuentes en la etapa preescolar.
- ★ . Empleo de métodos educativos incorrectos.
 - ❖ Procedimientos para estimular el desarrollo verbal.
 - ❖ Desconocer qué hacer y no hacer en el período de tartaleo fisiológico.
 - ❖ Desconocer qué hacer para evitar las dificultades y trastornos verbales.
 - ❖ Rigidez en la educación familiar, expresada en exigencias verbales y comportamentales elevadas.
 - ❖ Inconsistencia o permisividad en la educación familiar.

- ❖ Manejo inadecuado de problemas educativos en el hogar y la institución educativa.
- ★ Pudiera que además el niño presentara Retardo en el desarrollo del lenguaje.
 - ❖ Pobreza de vocabulario y en la construcción gramatical.
 - ❖ Insuficiente coordinación de los órganos articulatorios.
- ★ Otros factores sociopsicológicos que pueden influir desfavorablemente:
 - ❖ Clima emocional desfavorable en el medio familiar y la institución educativa por conflictos intensos o continuos como:
 - ❖ Peleas en el medio familiar
 - ❖ Sobreprotección de los padres
 - ❖ Padres muy exigentes con la educación de sus hijos
 - ❖ Profesores con malas pautas educativas, ofensas y malos tratos al escolar.
 - ❖ No superación de trastornos emocionales en la niñez como timidez, inadaptación neurótica, trastornos situacionales y trastornos incipientes de la personalidad.
 - ❖ Relaciones frecuentes con personas tartamudas.
 - ❖ Conflictos sistemáticos o de gran connotación en el entorno.

Así como usted intenta que su casa sea un lugar que brinde seguridad, también debe serlo para que su hijo pueda hablar cómodamente, sintiéndose seguro en ella.

Resulta pertinente que la familia conozca la ontogénesis del lenguaje esto les permitirá realizar un diagnóstico precoz, lo que posibilita un rápido acceso al tratamiento, que promueve la remisión total o reducción de los síntomas de la tartamudez, así como minimizar su impacto en la calidad de vida de los niños.

Ontogénesis del lenguaje o etapas del lenguaje: No es más que el desarrollo del lenguaje, constituyendo el proceso de aprendizaje sociofisiológico único e indivisible, en el que cada etapa y aspecto modifica a los restantes. Varios autores dividen este complejo proceso en tres etapas: Pre-lenguaje, Primer lenguaje y Lenguaje propiamente dicho, que seguidamente se da a conocer.

Pre-lenguaje: Inicia desde el llanto o grito inicial del recién nacido luego durante la sexta o séptima semana de vida las características están dadas por “murmullos”, “gorjeos”, y “vocalizaciones. Alrededor del cuarto o quinto mes de vida, se identifica porque en él comienza la audición a representar un papel importante comienzan las repeticiones o combinaciones de sonidos hasta el pronunciamiento de las primeras palabras en su valor de signos convencionales, al final del primer año de vida del niño. Esta etapa se caracteriza por repeticiones o combinaciones de sonidos, ya que el niño o niña han comenzado a escucharse, lo que le provoca una satisfacción considerable; el éxito en la imitación se convierte en su incentivo y estímulo para la repetición. Una de las combinaciones de sonidos más escuchadas y aún desde la etapa del balbuceo, es la de sonidos bilabiales primero monosilábicos y luego polisilábicos como por ejemplo “ma ma pa”, que tienen lugar desde antes de los 6 meses hasta el octavo o noveno mes. La trascendencia de esta etapa reside en que el niño o niña, aprenden a imitar sus sonidos, lo que repercute en el desarrollo del idioma que hablarán. Es esta primera etapa analizada, en el aspecto pragmático (uso práctico que el niño hace del lenguaje para satisfacer sus necesidades, controlar una situación e interactuar con quienes se relaciona para comunicar sus experiencias) el niño inicia la conversación temprana, en la cual utiliza el llanto, la mirada, la risa, la succión, entre otros, para establecer comunicación con su entorno de su desempeño dependerá la mayor o menor habilidad de comunicarse en el futuro.

Primer lenguaje: Este período se extiende sólo por algunos meses, observándose una progresiva aparición de frases estereotipadas que son idénticas a las del adulto que le rodea y de construcciones típicas de la lengua materna. En este último período el enunciado adquiere mayor complejidad se acerca al enunciado del adulto; el manejo de la palabra es más independiente y es cada vez más usada según la vaya adquiriendo, o sea, espontánea y voluntariamente. El orden de aparición de estas estructuras enunciativas es la afirmación, la orden la negación y la interrogación, siendo estos patrones melódicos y tonales los que constituyen las primeras verdaderas estructuras lingüísticas, que usan el niño y la niña con todo el vocabulario de que disponen.

Lenguaje propiamente dicho: El acceso al lenguaje propiamente dicho se caracteriza, por un abandono progresivo de las estructuras elementales del lenguaje infantil y de su vocabulario específico. La primera manifestación de esa evolución se traduce en el interés creciente del niño por el habla del adulto, en el gusto por historias o lecturas que les hagan, en la solicitud de que esto se repita continuamente. El lenguaje se convierte por sí mismo en un medio de conocimiento, en un sustituto de la experiencia directa y al mismo tiempo en un medio para comprenderla mejor, para organizar mejor sus datos inmediatos. Es el momento en que el juego mismo se convierte en palabras, siendo éste creador de situaciones y acciones. Existe una lenta evolución de la toma de conciencia del niño o niña de su “yo” conceptual, de sí como identidad, que no se manifiesta al principio en el lenguaje, que durante cierto tiempo, sólo hablará de sí en tercera persona, o en segunda, en imitación al adulto.

A qué llamamos “Tartaleo fisiológico”

Cuando los niños comienzan a hablar, en la etapa que se extiende entre los 2 y 6 años (etapa preescolar), suelen mostrarse problemas que forman parte de la evolución del lenguaje. Una comunicación no fluida muestra manifestaciones alteradas durante la comunicación y según la manera en que sean percibidas por el entorno familiar dificultarán o facilitarán la interacción comunicativa.

En las primeras edades alrededor de los tres años se produce un proceso de integración ideó verbal en los niños (tartaleo fisiológico) con presencia de titubeos, vacilaciones y repeticiones inconscientes e involuntarias por lo que la afectación es de forma inconsciente, identificándose el primer nivel de afectación inconsciente.

Cuando ya el modelo lingüístico no es el esperado por el niño, ni por el medio que lo rodea: sus padres, el proceso de retroalimentación del medio hacia él acerca su forma de hablar y la de sí mismo al escucharse y compararse con los demás, se conduce a la concientización de la dificultad por lo que la afectación pasa a ser consciente.

Una vez que surgen los espasmos y se hacen consciente, el niño trata de enmascarar el trastorno ante determinadas situaciones comunicativas a través de una ejecución voluntaria de la forma de hablar y por tanto se pierde el automatismo y espontaneidad del habla, se produce un rompimiento entre los sistemas de dirección voluntaria e involuntaria del paso del programa verbal a la fase de su enunciado externo, lo que se identifica como segundo nivel de afectación consciente y, por último, se instala la tartamudez afectándose la comunicación oral y el desarrollo de la personalidad, para un tercer nivel de afectación consciente. Por lo que se deduce que la tartamudez transcurre desde el plano inconsciente al consciente.

Es por ello, que para evitar el surgimiento y establecimiento de la tartamudez es preciso crear desde la familia un clima adecuado y lograr el compromiso y sensibilización de todos sus miembros para cumplir correctamente las orientaciones en aras de lograr una mejor educación para sus hijos.

CREANDO UN CLIMA APROPIADO EN CASA

Orientaciones a los padres de educandos que se encuentran en la etapa de tartaleo fisiológico.

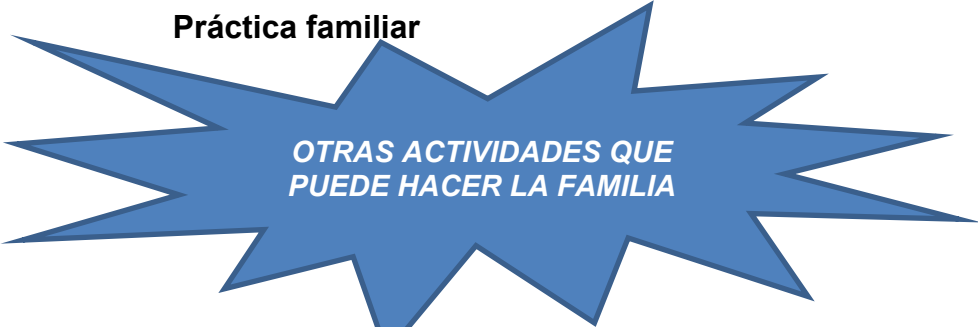
- ✦ Mantenga un horario de vida regular y estable, ese equilibrio influirá en el habla y ayudará mucho a su hijo.
- ✦ Cuide la armonía de su hogar y las relaciones entre todos los miembros de la familia, particularmente con su hijo, sin sobreprotección.
- ✦ Ante situaciones de enfermedades, ingresos y operaciones, manténgase controlado, apóyelo y no exagere su relevancia.
- ✦ Aumente la seguridad del niño en sí mismo al estimular sus logros en la escuela.
- ✦ Ayúdele con sus orientaciones con apoyo y cariño a resolver los problemas que enfrenta en la vida diaria: la escuela, el barrio, los amigos, la familia y otros momentos.
- ✦ Cuando ocurran problemas en su familia y la comunidad como desastres naturales, trate la situación con naturalidad, explíquele y ofrézcale toda la seguridad que le sea posible.
- ✦ Háblele despacio, con claridad, ritmo e intensidad normal, la mejor forma de ayudarlo es ofreciéndole un patrón verbal correcto.
- ✦ No le exija que hable cuando no sabe o no lo desea, sobre temas que no le agradan o ante personas desconocidas.
- ✦ Ayúdelo a aprender nuevas palabras llevándolo a pasear por lugares que nunca haya ido, leyéndole cuentos, aprendiendo canciones esto ayudará a enriquecer su vocabulario y con ello a sustituir algunas palabras por otras.
- ✦ No rectifique las expresiones incorrectas, particularmente cuando se “traba”; en todo caso repita la palabra o frase de forma correcta con cuidado y no le exija que hable cuando no sabe o no lo desea, sobre temas que no le agradan o ante personas desconocidas.
- ✦ No le haga preguntas constantemente, ni le pida que narre o describa hechos si sabe que en esas situaciones aparecerán las dificultades, ayúdele con su explicación.
- ✦ Evite hacer comentarios como: "habla más despacio", "no te pongas nervioso", "respira profundo", "relájate", pues en vez de ayudarlo hace que la situación se

torne más tensa y desagradable para él.

- ✦ Preste atención a su actividad, así descubrirá cuando tartamudea más y cuando menos. Esto le permitirá evitar o ayudarlo en las primeras situaciones y estimular las segundas.
- ✦ Preste atención a cuáles recursos emplea para hablar mejor, ayúdelo a que los incorpore con la mayor naturalidad posible a su comunicación.
- ✦ Utilice su autoridad educativa con afecto, respete siempre su individualidad y no le agreda.
- ✦ No provoque celos, no haga ni permita comparaciones innecesarias con hermanos, familiares o amigos, ya sean sobre su comunicación, comportamiento, físico o aprendizaje.
- ✦ Ayúdele a desarrollar actividades útiles que le permitan ganar confianza en sus posibilidades, no insista en las que demanden gran esfuerzo verbal como aprender idiomas.
- ✦ Evite hacer comentarios como **habla más despacio** o **no te pongas nervioso**. En lugar de ayudarlo, esos comentarios le pondrán más tenso y más nervioso.
- ✦ Baje el nivel de exigencia, hálblele con frases cortas y con un lenguaje fácil pero llamando a cada cosa por su nombre.
- ✦ Si durante la comunicación vacila, mantenga el contacto visual y no se avergüence, burle o ría de la situación.
- ✦ No adivine lo que le quiere decir ni le apesure para que termine de expresar sus ideas.
- ✦ No le ponga cara de susto o demuestre impaciencia al hablar con el niño.
- ✦ Escúchelo atentamente y propicie un clima relajado en el hogar, que estimule su habla.
- ✦ Explíquele con sencillez y sin pesimismo que no somos perfectos pero que depende mucho de los esfuerzos personales ser cada día mejor, deje claridad de su ayuda para lograrlo.
- ✦ Dígale que en la vida no todo sale bien que a veces nos equivocamos, perdemos o no logramos lo que queremos. Hágale ver cuán importante es superar la dificultad.

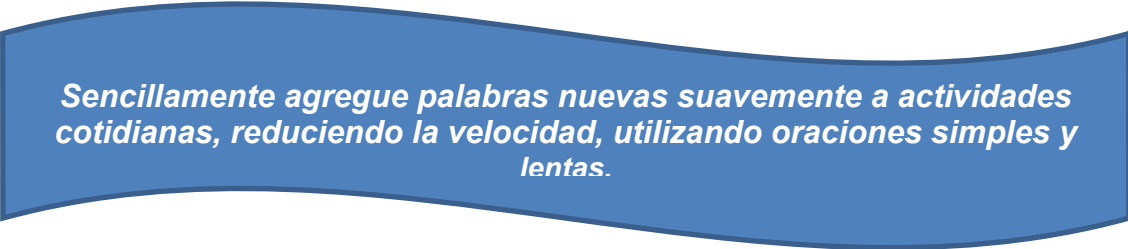
Recuerde que lo más importante es que su hijo sepa que usted le quiere y acepta como es y se comuniquen sin temores y con la confianza de que cada día lo hará mejor.

Práctica familiar



OTRAS ACTIVIDADES QUE PUEDE HACER LA FAMILIA

- 🎧 **Describir figuras de un libro.**
- 🎧 **Comentar sobre que hace cuando usted cocina.**
- 🎧 **O cuando prepara la ropa para lavar.**
- 🎧 **O a medida que vaya realizando sus tareas domésticas.**
- 🎧 **Hablando de los personajes y argumentos de programas de TV.**
- 🎧 **Describiendo un juego.**
- 🎧 **Describiendo la ropa a medida que se va vistiendo.**



Sencillamente agregue palabras nuevas suavemente a actividades cotidianas, reduciendo la velocidad, utilizando oraciones simples y lentas.

El presente folleto se ha realizado con el propósito de llevar a todas las familias cubanas una mejor vía de preparación y conocimiento sobre cómo prevenir la tartamudez identificando los factores de riesgo, las pautas a seguir en la etapa de tartaleo fisiológico y como la familia puede contribuir a la prevención del trastorno de una forma más simple y de fácil aplicación desde su rol diario. En consonancia con la propuesta y sus características para ser aplicada se procede a:

2.4 Valoración de la propuesta mediante la Consulta a Especialistas: (anexo7)

Con el objetivo de validar preliminarmente la propuesta. Se aplica a 5 especialistas. Los criterios que se tuvieron en cuenta para seleccionar los especialistas fueron los siguientes: que tuvieran más de 10 años de experiencias evaluados de excelente y muy bien de los cuales 2 son Máster en ciencias de la educación y 3 Licenciados lo que representa un 40% de máster y un 60% de licenciados.

Para lo que se propuso como criterio de clasificación:

Muy adecuada Adecuada Poco adecuada

Los resultados fueron los siguientes:

- En cuanto a la estructura el 40% la considero de muy adecuada y el 60% restante de adecuada.
- Según la calidad el 80% de muy adecuada y el 20 % de adecuada.
- Referido a la actualidad el 60% la consideró de muy adecuada y el 40% de adecuada.
- En cuanto a la correspondencia el 80% la evaluó de muy adecuada y el 20% de adecuada.
- Referido a la funcionabilidad el 60% la consideró muy adecuada y el 40% de adecuada.
- En cuanto a la accesibilidad el 80% la consideró de adecuada y el 20% muy adecuada.

2.5 Análisis de los resultados de constatación final

Para la constatación final se aplicó como instrumento la guía de entrevista a padres con el objetivo de evaluar el nivel de la orientación familiar sobre la prevención de la tartamudez en la etapa preescolar después de aplicado el folleto, sus resultados:

- En el **indicador I** nivel de conocimiento de las familias sobre el período de disfluencia verbal (tartaleo fisiológico) y la tartamudez se evaluó de alto para el 80% de las familias que componen el grupo de estudio y medio para el 20% restante pues se sienten más informados sobre el tema y cómo brindar una ayuda oportuna a sus hijos en la etapa de tartaleo fisiológico.

- En relación con el **indicador II** nivel de conocimiento de las familias sobre los factores de riesgo para el surgimiento de la tartamudez se evaluó de alto para el 60% de las familias y medio para el 40% ya se sienten orientados e informados sobre los factores desencadenantes o predisponentes para el surgimiento de la tartamudez.
- El **indicador III** Frecuencia de orientación familiar sobre la prevención de la tartamudez en la etapa preescolar se evaluó de alto para 100% de las familias pues se sienten más orientadas para prevenir la tartamudez debido a la contribución del folleto de orientación familiar para la prevención de la tartamudez como una ayuda más a los programas orientadores y preventivos de la escuela.
- En el **indicador 4** Nivel de conocimiento de acciones para prevenir la tartamudez se evaluó de alto para el 100% de las familias, refieren que mediante el folleto de orientación familiar para la prevención de la tartamudez han adquirido conocimientos sobre qué acciones pueden realizar para prevenir la tartamudez.

2.6 Test de Satisfacción

Los indicadores de calidad de la propuesta se evaluaron por criterio de usuario permitiendo aplicar un Test de Satisfacción familiar, por lo que sus resultados evidencian que el 100% de las familias refieren que las acciones de orientación familiar propuestas para la prevención de la tartamudez han sido instructivas ya que con ellas aprendieron qué acciones realizar en la etapa del tartaleo fisiológico para evitar el surgimiento de la tartamudez y han cambiado algunas ideas sobre su trato hacia el niño en esta etapa, por lo que evaluaron al folleto de orientación familiar para la prevención de la tartamudez en la etapa preescolar de adecuado.

Se corrobora que la propuesta es viable, factible y valorada desde una mirada integrada de las ciencias con el desarrollo local a partir de las acciones que se aplican para la prevención de la tartamudez desde edades tempranas del desarrollo del niño.

CONCLUSIONES

- El análisis de los referentes teóricos metodológicos y el estudio bibliográfico realizado acerca de la orientación familiar para la prevención de la tartamudez en la etapa preescolar evidencia que se hace necesario orientar a las familias para desde su contexto, lograr estadios superiores de desarrollo del lenguaje y evitar la aparición de la tartamudez.
- El diagnóstico del estado inicial de la orientación familiar reveló las dificultades existentes acerca de la insuficiente información y orientación que las familias tienen sobre el tema, y cómo no se desarrollan adecuadamente programas y estrategias en las escuelas para ampliar sus conocimientos.
- La propuesta de folleto de orientación familiar para la prevención de la tartamudez tiene como características: la vinculación de la teoría con la práctica y la unidad entre la actividad y la comunicación para el desarrollo de la personalidad así como el vínculo: familia, escuela, comunidad en acciones orientadoras para una mejor inclusión social y educativa del educando.
- La valoración realizada por los especialistas permitió evidenciar que la estructura, calidad, actualidad, correspondencia, funcionabilidad y accesibilidad del folleto fue de adecuada y cumplió con niveles altos de satisfacción por los usuarios.

RECOMENDACIONES

- Continuar la profundización en los contenidos teóricos-metodológicos relacionados con la orientación familiar para la prevención de la tartamudez en la etapa preescolar.
- Extender la propuesta hacia otros contextos comunitarios.
- Divulgación de los resultados obtenidos en eventos científicos y otros espacios de intercambio y socialización, con el fin de mejorar la situación actual acerca de la orientación familiar para la prevención de la tartamudez en la etapa preescolar.
- Continuar perfeccionando el trabajo realizado para mejores resultados en la práctica futura.

BIBLIOGRAFÍA

1. Arés Muzio, P. (1990) Mi familia es así. La Habana: Ed. Pueblo y Educación.
2. ----- . (2002) "Psicología de la familia. Una aproximación a su estudio" La Habana.
3. ----- . (2004) Familia y convivencia. La Habana: Ed. Científico Técnico.
4. Arredondo, Kassabb. M.M.(2016)REDIPE Artículo científico: Educar para la Vida.978-958-8667-13-4 Cuba -Colombia 13-14 JUNIO.
5. Álvarez de Zayas, C. (1996). "Hacia una escuela de excelencia". La Habana. Cuba: Editorial Academia.
6. Brito Perea, T. (2002) La educación familiar. La Habana: Ed. Pueblo y Educación.
7. Bell, R. (2008). Educación vs. Exclusión. Dos aportes de la educación cubana a la superación de la exclusión. (p.22). La Habana. Cuba: Editorial Pueblo y Educación.
8. Biaint de Touzet, B. (1995) Prevención Primaria en tartamudez o una manera de ocuparnos tempranamente de este síntoma. Buenos Aires: Ed. Revista Ecos Fono audiológico.
9. BORGES, S. A. (2014)"La Inclusión Educativa y la superación del docente de diferentes niveles de educación". Seminario Científico – Metodológico. Universidad de Ciencias Pedagógicas: "Rafael María de Mendive": Ed Pinar del Río, Cuba.
10. Borges, S. A.; Leyva, M.; Zurita, C. R. (2015) La Pedagogía Especial. Sus fundamentos generales. Pedagogía Especial e Inclusión Educativa. La Habana. Cuba: Ed Cubana.
11. CASTRO ALEGRET, P. L. Y CASTILLO SUÁREZ, S. M. (1999) Para conocer mejor a la familia. Una propuesta de evaluación desde la escuela. Editorial Pueblo y Educación.

12. Cabanas Comas, R. (1979). Acerca de una teoría sobre el origen del habla en la humanidad con desviaciones terapéuticas. Revista Hospital Psiquiátrico de La Habana. __ Ciudad de La Habana: Ed. Pueblo y Educación.
13. Colectivo de autores. (1973) Higiene mental en el ambiente de la tartamudez inicial. Aspectos preventivos y terapéuticos. Revista cubana de Pediatría 45 __ Ciudad de La Habana: Ed. Pueblo y Educación.
14. -----.(1974). Procedimientos específicos, profilácticos y terapéuticos en la tartamudez inicial. Revista cubana de Pediatría 47 __ Ciudad de La Habana: Ed. Pueblo y Educación.
15. -----: (2013) Educa a tu hijo, Gestantes. __ Ciudad de La Habana: Ed Pueblo y Educación
16. CABALLERO, E. (2002). Diagnóstico y Diversidad. Selección de lecturas: Ed. Pueblo y Educación. La Habana, Cuba.
17. COBAS OCHOA, C; L. (2007) La preparación logopédica del docente. __ Ciudad de La Habana: Ed. Pueblo y Educación.
18. CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DE CUBA. Publicaciones Oficiales del Ministerio de Justicia. __ La Habana: Orbe, 1992. Collazo Delgado, B. La orientación en la actividad pedagógica/ Basilia Collazo Delgado, María Alba. __ La Habana: Ed. Pueblo y Educación, [1992](#). __ p. 1-35.
19. DINVILLE, C. (1992) "La tartamudez, sintomatología y tratamiento. Editorial Masson S. A. Buenos Aires.
20. FERNÁNDEZ PÉREZ DE ALEJO, G. (1993) La rítmica logopédica en el tratamiento de la tartamudez. Editorial Pueblo y Educación.
21. FERNÁNDEZ PÉREZ DE ALEJO, G. Y LÓPEZ HERNÁNDEZ, M. (1986) ¿Qué conocemos acerca de la historia de la Logopedia en Cuba? Revista Varona VIII, (24-34), La Habana, Junio.
22. Fernández Collado, C. ([1989](#)) La comunicación humana/ C. Fernández Collado. L. Dahnke. __ La Habana: Ed. C. Sociales.
23. HERNÁNDEZ SAMPIERI, R. Y COLS. (1991) Metodología de la investigación. Mc Graw Hill Interamericana de México S. A.

24. Hernández, A. (1997) Orientación familiar en la tartamudez inicial. , ISPEJV, La Habana.
25. Ibarra, L. (1993) "Orientación Familiar: un debate permanente." La Habana. La Tartamudez: guía de prevención y tratamiento infantil. (1993) Editorial Pirámide S. A. Madrid, España, Segunda Edición.
26. Martín, O. (1994) El niño tartamudo y su entorno familiar., ISPEJV, La Habana.
27. Martínez C. (2001) Salud familiar. La Habana: Editorial Científico Técnica.
28. SAVATER, F. (1997). El valor de educar. Barcelona: Ariel
29. http://www.depadresahijos.org/valores/familia_importancia.html
30. ----- . (2005) Para que la familia funcione bien: Ed Científico Técnico, La Habana.
31. Montero, M. y otras. (1998). Prevención de la tartamudez. , ISPEJV, La Habana.
32. PÉREZ SERRANO, E. (1997) Variante de intervención para escolares tartamudos. Revista Electrónica Luz. Holguín, Julio.
33. Rico, P., et al. (2002). Hacia el perfeccionamiento de la escuela primaria. La Habana. Cuba: Editorial Pueblo y Educación. p.50.
34. Rodríguez Fleitas, X. y Padrón Francisco, I. MATERIAL DE ESTUDIO SOBRE LOS TRASTORNOS DEL RITMO Y FLUIDEZ VERBAL.) Revista Cubana de Pediatría. (1978) Diagnóstico diferencial temprano entre tartamudez y tartaleo.
35. TRAVIESO E.(2008). El desempeño profesional y humano de los promotores del Programa "Educa a tu hijo", en la atención educativa integral a los niños con indicadores de un posible retraso mental. [Tesis en opción al grado científico de Doctor en Ciencias Pedagógicas]. La Habana, Cuba: ISPEJV.
36. VÁZQUEZ, J.(2001) Propuesta Metodológica para favorecer al desarrollo de la comunicación en niños con Parálisis Cerebral en edad preescolar. [Tesis de Maestría]. Universidad de Ciencias Pedagógicas "Enrique José Varona" La Habana, Cuba.

37. VIGOTSKY, L. S. (1982). Pensamiento y Lenguaje. La Habana, Cuba: Ed Pueblo y Educación.
38. ----- (1987) Historia del desarrollo de las funciones psíquicas superiores. Ciudad de la Habana: ED Científico Técnico.

ANEXOS

Anexo 1

Relación de indicadores, parámetros e instrumentos.

Indicadores	Parámetros	Instrumento
I. Nivel de conocimiento de las familias sobre el período de disfluencia verbal (tartaleo fisiológico) y la tartamudez.	Alto: Las familias conocen sobre el tartaleo fisiológico y la tartamudez y que actividades a realizar para evitar el surgimiento de la tartamudez. Medio: Las familias poseen algunos conocimientos sobre el período de disfluencia verbal (tartaleo fisiológico) y sobre la tartamudez. Bajo: Las familias desconocen sobre el período de disfluencia verbal (tartaleo fisiológico) y sobre la tartamudez.	Guía de entrevista a padres
II. Nivel de conocimiento de las familias sobre los factores de riesgo para el surgimiento de la tartamudez.	Alto: Conocen sobre los factores de riesgo para el surgimiento de la tartamudez, saben la importancia de conocer las etapas por las que transita el lenguaje y que acciones que se pueden llevar a cabo en la etapa de tartaleo fisiológico para prevenir la tartamudez. Medio: Poseen algunos conocimientos sobre los factores de riesgo para el surgimiento de la tartamudez, la importancia de conocer las etapas por las que transita el lenguaje y conocen algunas acciones que se pueden llevar a cabo en la etapa de tartaleo fisiológico Bajo: Desconocen los factores de riesgo para el surgimiento de la tartamudez, no saben la importancia de conocer las etapas por las que transita el lenguaje y	Guía de entrevista a padres

	no conocen acciones que se pueden llevar a cabo en la etapa de tartaleo fisiológico	
III. Frecuencia de orientación familiar sobre la prevención de la tartamudez en la etapa preescolar.	Siempre: Se sienten suficientemente orientadas sobre cómo prevenir la tartamudez. Se desarrollan exitosamente los programas preventivos y orientadores en la escuela. Casi siempre: Poseen conocimientos sobre la tartamudez, saben cómo prevenirlo y se desarrollan adecuadamente los programas preventivos y orientadores. Nunca: Insuficientes conocimientos sobre cómo prevenir la tartamudez desde su rol familiar. No se desarrollan los programas preventivos y orientadores adecuadamente.	Guía de entrevista a padres. Encuesta a docentes y directivos de la escuela
IV. Nivel de conocimiento de acciones para prevenir la tartamudez.	Alto: Conocen sobre la ontogénesis del lenguaje: el gorjeo, el balbuceo, vocalizaciones y la aparición progresiva de frases estereotipadas hasta llegar al lenguaje propiamente dicho y ayudan a estimular dicho proceso. Medio: Poseen algunos conocimientos sobre las etapas por las que transita el lenguaje: el gorjeo, balbuceo, vocalizaciones, la aparición progresiva de las frases estereotipadas hasta llegar al lenguaje propiamente dicho. Bajo: Desconocen las etapas por las que transita el lenguaje: el gorjeo, balbuceo, vocalizaciones, la aparición progresiva de las frases estereotipadas hasta llegar al lenguaje propiamente dicho además no	Guía de entrevista a padres. Guía de observación a la familia

	estimulan dicho proceso.	
--	--------------------------	--

Anexo 2

Guía para el Análisis documental.

Objetivo: Sistematizar la información de textos científicos de orientación familiar para la prevención de la tartamudez en la etapa preescolar y de documentos rectores y legales.

- 1- Revisión de documentos normativos y legales.
- 2- Exploración logopédica.

ANEXO 3

Guía de entrevista a padres, docentes y directivos.

Objetivo: Evaluar el nivel de la orientación familiar sobre la prevención de la tartamudez en la etapa preescolar.

I. Nivel de conocimiento de las familias sobre el período de disfluencia verbal (tartaleo fisiológico) y la tartamudez.

¿Usted conoce a que se le llama período de disfluencia verbal o tartaleo fisiológico?

¿En qué edad se manifiesta y cuáles son sus principales características?

¿Sabía usted que el mal manejo de esta etapa puede desencadenar en su hijo la tartamudez?

¿Conoce que es la tartamudez y sus principales características?

¿Sabe que actividades se pueden realizar con el niño para prevenir la tartamudez?

¿Le interesa ampliar sus conocimientos sobre cómo prevenir la tartamudez para poder brindarle una oportuna ayuda a su hijo?

¿Cómo desde su rol familiar puede lograr que estas orientaciones sean más eficaces?

II. Nivel de conocimiento de las familias de los factores de riesgo para el surgimiento de la tartamudez.

¿Conoces algunos factores de riesgo para el surgimiento de la tartamudez?

¿Sabías que el niño puede desarrollar tartamudez por convivir con una persona tartamuda?

¿Conoces las diferentes etapas por las que transita el lenguaje?

¿Qué puedes hacer y no hacer en la etapa de tartaleo fisiológico?

¿Sabías que la rigidez en la educación familiar, expresada en exigencias verbales y comportamentales puede incidir en el lenguaje del niño?

III. Frecuencia de orientación familiar sobre la prevención de la tartamudez en la etapa preescolar.

¿En la escuela se realizan programas orientadores a la familia?

¿Con que frecuencia?

¿Conoce usted que es la tartamudez?

¿Se siente lo suficientemente orientado sobre el trastorno?

¿Cómo puede usted desde su rol familiar contribuir a la prevención, corrección y/o compensación del trastorno?

IV. Nivel de conocimiento de acciones para prevenir la tartamudez.

¿Cuándo su hijo presenta tropiezos y vacilaciones en el lenguaje que hace usted al respecto?

¿Conoce acciones que pueda realizar para estimular el lenguaje de su hijo?

¿Usted le exige a su hijo ser un modelo lingüístico para comunicarse?

¿Usted conoce que acciones se pueden realizar en la etapa de tartaleo fisiológico para prevenir el surgimiento o establecimiento de la tartamudez?

¿Considera oportuna la orientación a la familia para prevenir la tartamudez?

MUCHAS GRACIAS

Anexo 4

Guía de observación a la familia

Objetivo: Constatar que papel asume la familia para estimular el desarrollo del lenguaje oral en sus hijos durante el desarrollo de las actividades lúdicas.

Aspectos a observar:

1- Disposición de la familia para estimular el lenguaje oral en su hijo:

☐ Buena ☐ Regular ☐ Mala

2- Papel de la familia durante las actividades lúdicas con el niño

☐ activo ☐ pasivo

3- Conocimientos de la familia acerca de la estimulación del lenguaje en la etapa preescolar:

☐ Suficiente ☐ Poco suficiente ☐ Insuficiente

4- Peculiaridades del lenguaje de la familia:

☐ Rico ☐ Pobre ☐ Regular

5- ¿Durante el desarrollo de las actividades cómo fue el trato con el niño?

☐ Bueno ☐ Malo ☐ Regular

6- ¿Cómo reacciona la familia ante los errores del niño?

☐ Bien ☐ Mal ☐ Regular

7- Conducta durante la actividad.

☐ Buena ☐ Mala ☐ Regular

MUCHAS GRACIAS

ANEXO 5

Técnica de exploración logopédica (inicial)

Objetivo: Explorar el desarrollo de la comunicación oral de los escolares que componen la muestra.

Aspectos a tener en cuenta durante la exploración logopédica.

1. Datos generales.
2. Motivo de consulta.
3. Estudio anamnésticos.
4. Valoración del estado de los sistemas sensoriales.
5. Valoración del lenguaje impreso y expresivo.
6. Caracterización del ritmo y fluidez del lenguaje.
8. Valoración de diferentes aspectos de la personalidad.
9. Conducta.
10. Diagnóstico logopédico.

Resultados de la exploración logopédica inicial

CONSTATACIÓN INICIAL

Indicadores	Superado	%	Ligeramente superado positivo	%	Ligeramente superado	%
Respiración	_0	—	_0	—	5	
Expresión oral	_0	—			5	
Relaciones	_3	—	2		0	

interpersonales						
-----------------	--	--	--	--	--	--

MUCHAS GRACIAS

Anexo 6

Encuesta a docentes y directivos de la escuela:

Objetivo: Constatar la frecuencia de orientación familiar sobre la prevención de la tartamudez en la etapa preescolar.

Marque con una x la respuesta según su caso.

	SUFICIENTES	POCO SUFICIENTES	INSUFICIENTES
En la escuela se realizan actividades y talleres de orientación familiar.			
Se realiza adecuadamente el programa Educa a tu hijo y las vías no formales.			
Se realizan actividades con el niño para el desarrollo de su vocabulario.			
Son suficientes las orientaciones que recibe			

la familia sobre las etapas del lenguaje			
Se realizan acciones para la prevención de la tartamudez en la etapa preescolar.			

MUCHAS GRACIAS

Anexo 7

Cuestionario de consulta a especialista.

Objetivo: validar preliminarmente la propuesta.

Para el procesamiento de este instrumento se precisa además de la información siguiente:

Nombre y Apellidos, categoría científica, categoría docente, años de experiencia y cargo.

Compañero(a):

Se pide su colaboración en la realización de la presente investigación en aras de lograr mayor efectividad en la propuesta diseñada con vistas a la orientación familiar para la prevención de la tartamudez. Marque con una X, en la escala cualitativa que se presenta, su criterio en cuanto a la propuesta que se le presenta.

Criterios valorativos	Categorías ordinales			
	Muy adecuado	Adecuado	Poco adecuado	No adecuado
Estructura	2	3		
Calidad	4	1		
Actualidad	3	2		

Correspondencia	4	1		
Funcionalidad	3	2		
Accesibilidad	1	4		

Además consideraremos cualquier otro criterio o sugerencia que pueda darnos en cuanto a:

- 1 Si las orientaciones propuestas se corresponden con el objetivo de la investigación.
- 2 Si las orientaciones propuestas están organizados de forma gradual.
- 3 Si la estructura de las orientaciones está concebida metodológicamente.
- 4 Si resulta necesario agregar o suprimir algunas de las orientaciones propuestas.
- 5 Si usted considera necesario alguna variación en la estructura de la propuesta.

A continuación presentamos la propuesta en espera de su colaboración que resultará de mucha ayuda en el cumplimiento del objetivo de la investigación.

Sus criterios permitirán conocer la efectividad de la misma de conjunto con los restantes métodos de investigación que se aplicarán.

Cualquier otra recomendación que no se corresponda con los parámetros sugeridos inicialmente, serán agradecidos igualmente.

MUCHAS GRACIAS

Anexo 8

Test de satisfacción familiar.

Objetivo: Conocer la opinión de la familia sobre el folleto de orientación familiar para la prevención de la tartamudez.

Estimada familia:

Para valorar la efectividad del folleto de orientación familiar le pedimos colabore nuevamente respondiendo con la mayor sinceridad posible las siguientes preguntas.

1- Las actividades de orientación familiar propuestas para la prevención de la tartamudez han sido:

- ☐ Aburridas
- ☐ Instructivas
- ☐ Poco interesantes
- ☐ Interesantes

2- Con ellas ha aprendido:

☐ Poco ☐ nada ☐ algo ☐ mucho.

3- Considero que:

- ☐ He aprendido cosas nuevas.
- ☐ He consolidado lo que ya sabía.

__He cambiado algunas ideas.

__ He reafirmado las ideas que ya tenía.

__ Aún tengo dudas.

__ He aclarado dudas.

__ Tengo dudas nuevas

4-¿Está dispuesto a formar parte de este proyecto aplicando el folleto a su hijo?

_si _no

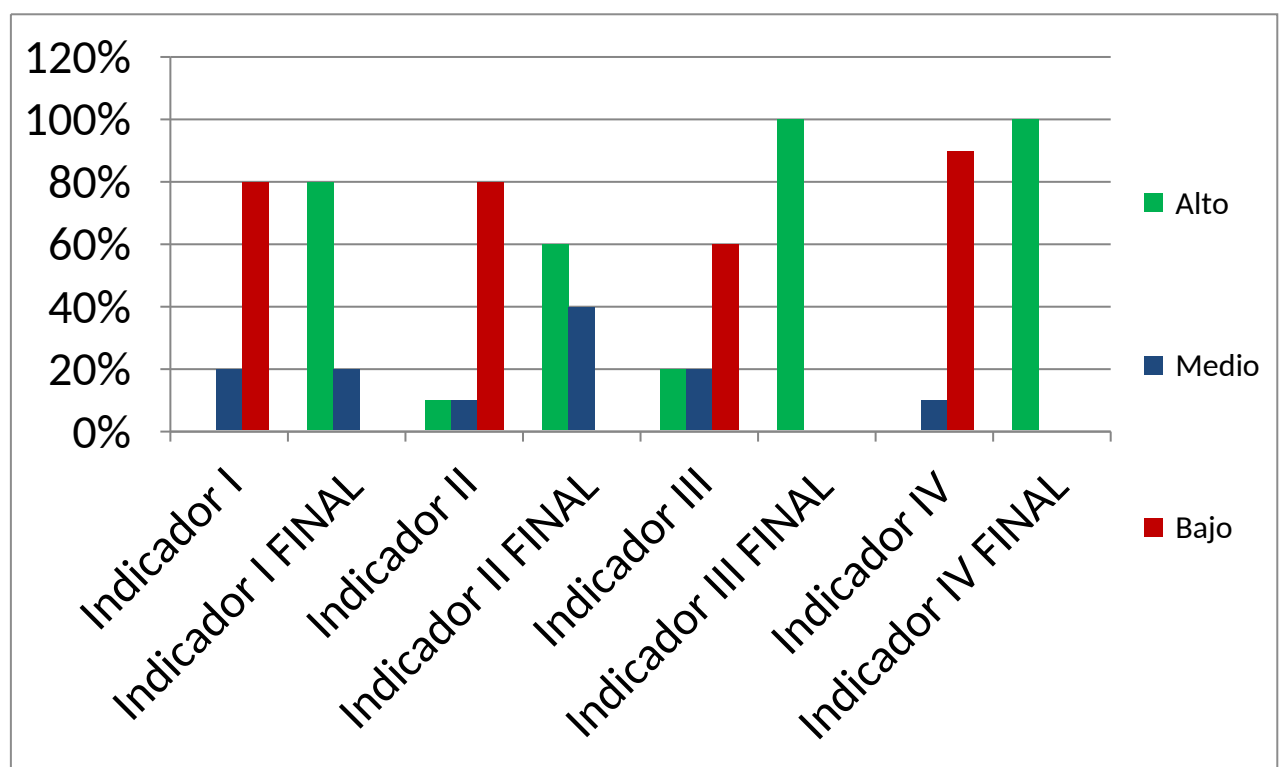
5-Le brindaría al folleto una evaluación de:

_poco adecuada _adecuada _muy adecuada

MUCHAS GRACIAS

Anexo 9

Comparación del resultado inicial y final



Anexo 10

Durante la aplicación del folleto de orientación familiar para la prevención de la tartamudez en la etapa preescolar.



Muchas gracias